

淺談坊間助眠藥物

吳芳芝

粒粒生技有限公司藥劑部

摘要

隨著台灣成人睡眠問題的增加，藥師在協助患者管理睡眠障礙時，需從多方面考量。助眠藥物的選擇不僅要改善睡眠品質，還需提升患者日間功能。常用藥物包括抗組織胺類藥物、褪黑素、抗憂鬱藥物及苯二氮平類安眠藥等。抗組織胺類藥物能鎮靜，但在老年患者中易引發抗膽鹼副作用。褪黑素有助調節生物節律，但長期使用需注意劑量。抗憂鬱藥物低劑量可改善睡眠，但需謹防血壓過低等副作用。苯二氮平類藥物因易產生依賴性，不適合長期使用，非苯二氮平類則副作用相對較少。藥師需依據患者具體情況，綜合健康狀況及合併用藥，制定最適合的助眠方案，以最大化療效並減少不良反應。

關鍵字：助眠藥物、失眠、睡眠品質、副作用、苯二氮平類、褪黑素

壹、簡介

近年來的調查和研究，台灣的睡眠狀況不理想。其中以睡眠時間不足最嚴重，許多台灣成年人每天睡眠時間不足7小時，在工作壓力大的都市人群中更是明顯。其次是失眠問題，許多人報告有失眠症狀，如難以入睡、夜間醒來和早醒。睡眠品質差也是另一個重要的狀況，高達四分之一的人認為睡眠品質差，常感到白天疲憊不堪。生活習慣是造成睡眠障礙的重要原因，使用電子設備、晚睡、以及生活

及工作壓力大是影響睡眠的重要因素。睡眠的重要性，包括細胞與組織的修復和再生，身體在睡眠中修復肌肉、合成蛋白質和釋放生長激素。免疫系統也有很重要影響，睡眠不足會降低免疫系統，更易感染疾病。心血管健康也同樣的重要角色，良好的睡眠有助於維持心血管健康，降低高血壓、心臟病和中風風險。心理功能也受到睡眠的衝擊。睡眠對記憶鞏固和學習能力至關重要，缺乏睡眠會影響認知功能和專注力。睡眠不足與焦慮、抑鬱和其他情

通訊作者：吳芳芝／電子信箱：wufatw@gmail.com

緒問題密切相關。

失眠的型態有入睡困難（初期失眠），維持睡眠困難（中期失眠）以及早醒（末期失眠），常見原因有焦慮、壓力、興奮、作息不規律、環境變化。抑鬱、慢性疼痛、夜尿增多、睡眠呼吸中止症、週期性肢體運動障礙，年齡增大以及環境因素（如光線或噪音）。

處理睡眠障礙，最初的方式是重新審視睡眠衛生，維持規律的作息時間，創造舒適的睡眠環境。避免睡前刺激性活動和飲食。接下來是行為治療，認知行為療法（CBT-I），放鬆技巧，如冥想和深呼吸。助眠藥物的角色，主要用於短期緩解嚴重失眠症狀，幫助患者恢復正常睡眠模式，但不建議長期依賴。本文將探討藥師在使用坊間助眠藥物時應遵循的原則與注意事項，涵蓋抗組織胺、褪黑素、抗憂鬱藥物、抗精神藥物、苯二氮平安眠藥與非苯二氮平安眠藥、乙醯膽鹼刺激劑、pramipexole、乙醯膽鹼酯酶抑制劑、抗癲癇藥物、抗膽鹼藥物及肌肉鬆弛劑。藥師必須了解各種藥物的使用原則與注意事項。

貳、助眠藥物使用原則

助眠藥物的主要目的是改善睡眠品質，提高日間的功能表現。推薦助眠藥物時應考慮以下幾個原則：一、評估患者的睡眠問題，了解患者的睡眠問題為短期或長期，確定是否有潛在的健康問題或正在使用其他藥物。二、選擇合適的藥物，根據患者的具體情況選擇合適的助眠藥物。常見的助眠藥物包括苯二氮平類藥物、非苯二氮平類鎮靜劑、褪黑激素等。三、考

慮藥物的副作用和相互作用，了解助眠藥物的副作用和與其他藥物的相互作用，並向患者解釋這些風險。

參、個別藥物介紹

以下介紹常見的助眠藥物提供藥師在諮詢時參考。

一、苯二氮平類藥物

苯二氮平類藥物（benzodiazepines）是一類中樞神經系統抑制劑，常用作鎮靜劑、抗焦慮藥物、抗癲癇藥物，以及助眠藥物^{1,2}。常見的苯二氮平類藥物包括地西泮（diazepam），阿普唑侖（alprazolam），和氯硝西泮（clonazepam）。作用機轉是通過增強 γ -氨基丁酸（GABA）的作用來發揮其藥理作用。GABA是一種主要的抑制性神經遞質，能夠減少神經元的興奮性。苯二氮平類藥物與GABA受體結合，增加氯離子通道開放的頻率，從而加強GABA的抑制效果，達到鎮靜、催眠、抗焦慮和抗癲癇的作用。

可能副作用，使用苯二氮平類藥物可能會引發嗜睡，依賴性與成癮性以及突然停藥可能引發戒斷症狀。還有認知功能障礙，運動協調性降低，在高劑量或與其他中樞神經抑制劑合用時，可能會抑制呼吸。

可能交互作用^{1,2}，如酒精會加強中樞神經抑制作用，增加呼吸抑制和鎮靜作用。抗抑鬱藥（如SSRI），能增加鎮靜效果。抗癲癇藥（如苯妥英），增加藥物代謝酶的活性，改變藥物濃度。與鴉片類藥物，增加呼吸抑制風險。肌肉鬆弛劑，用於減輕肌肉緊張和疼痛，幫助放鬆和入

睡，但也有副作用，如嗜睡和頭暈。

二、非苯二氮平類藥物

非苯二氮平類藥物 (Non-benzodiazepinedrugs)³⁻⁵ 主要包括下列幾個類別：Z-藥物 (如：zolpidem、zaleplon、eszopiclone)、抗焦慮藥物 (例如：buspirone)、鎮靜劑和催眠劑 (例如：ramelteon)、抗抑鬱藥物 (某些抗抑鬱藥物也具有鎮靜作用)。還有肌肉鬆弛劑 (baclofen, cyclobenzaprine)。

不同藥物的作用機轉各有不同，大多數是通過影響大腦中的神經傳遞物質來達到治療效果。以Z-藥物為例：zolpidem、zaleplon和eszopiclone，主要作用於GABA受體的 $\alpha 1$ 亞型，從而產生鎮靜和催眠效果。Buspirone主要作用於5-HT_{1A}受體，從而減少焦慮。Ramelteon：作用於褪黑激素受體，從而調節睡眠-覺醒週期。

藥物可能的副作用，有頭暈、嗜睡、頭痛、記憶力減退、睡眠行為異常 (如夢遊)。Buspirone：頭痛、頭暈、噁心、神經緊張。Ramelteon：疲勞、頭暈、嗜睡。

可能與多種其他藥物交互作用，如中樞神經抑制劑，如酒精、麻醉劑，加重鎮靜作用。CYP3A4抑制劑，如酮康唑、紅黴素，增加Z-藥物的血漿濃度。CYP3A4誘導劑，如利福平，可能降低Z-藥物的血漿濃度。

三、抗憂鬱藥

抗憂鬱藥是一種用來治療憂鬱症和其他相關心理疾病的藥物⁶。憂鬱症是一種會讓人感到持續悲傷、對事

情失去興趣的疾病。抗憂鬱藥有幾種不同的類型，每種藥物的作用方式都有所不同。主要的類型有選擇性血清素再攝取抑制劑 (SSRIs)，如：百憂解 (fluoxetine)，左洛復 (sertraline)。血清素和去甲腎上腺素再攝取抑制劑 (SNRIs) 如欣百達 (duloxetine)，艾司西酞普蘭 (escitalopram)。三環類抗憂鬱藥 (TCAs) 如：丙咪嗪 (imipramine)，阿米替林 (amitriptyline)。單胺氧化酶抑制劑 (MAOIs) 如：苯乙肼 (phenelzine)，異卡波胺 (isocarboxazid)。

抗憂鬱藥的主要作用是調節大腦中的化學物質，即神經傳導物質 (如血清素、去甲腎上腺素和多巴胺)，影響我們的情緒和感覺。

不同類型的藥物副作用不同，有口乾，頭暈，睡眠問題，胃腸不適，體重變化，性功能障礙。交互作用。如SSRIs和MAOIs同時使用可能導致嚴重的高血壓危險。與血液稀釋劑 (如阿司匹林) 一起使用時，可能增加出血風險。

特別注意的是如有心臟病，使用某些抗憂鬱藥可能會增加心律不整的風險。如果有癲癇，某些抗憂鬱藥可能會增加發作風險。

四、抗精神病藥

抗精神病藥物是一類專門用來治療精神疾病的藥物^{7,8}，像是精神分裂症、躁鬱症等。這些藥物可以幫助患者減少或消除症狀，比如幻覺、妄想、情緒波動等。

抗精神病藥物分為兩大類：第一代抗精神病藥 (典型抗精神病藥) 如氯丙嗪

(chlorpromazine)、哈爾多(haloperidol)，藥物主要通過阻斷大腦中的多巴胺受體作用。多巴胺是神經傳導物質，與情緒和思維有關。第二代抗精神病藥(非典型抗精神病藥)，如利培酮(risperidone)、奧美拉(olanzapine)。不僅阻斷多巴胺受體與血清素，有助於改善情緒症狀和減少副作用。

可能的副作用在第一代抗精神病藥有口乾、體重增加、便秘、疲倦，少數嚴重有肌肉僵硬、震顫(顫抖)、急性運動障礙(稱為錐體外系症狀)。第二代抗精神病藥會有體重增加、糖尿病風險增加、嗜睡。少數嚴重會有心臟問題、嚴重的過敏反應。

交互作用與抗抑鬱藥，會增加嗜睡或影響血糖濃度。與心臟藥物，會影響心臟的功能，增加心律不整的風險。

抗精神藥物(antipsychotics)主要用於治療精神病症狀，例如思覺失調症(精神分裂症)或躁鬱症。某些抗精神藥物也被用來輔助助眠，特別是當傳統的安眠藥物(如苯二氮卓類藥物)無法達到預期效果時。這些藥物的助眠機轉主要與它們對神經遞質(如多巴胺、血清素和組胺)的作用有關。

抗精神藥物的助眠機轉是阻斷多巴胺受體(特別是D2受體)，多巴胺是與警覺性和興奮性有關的神經遞質。阻斷多巴胺受體可以降低中樞神經系統的活性，進而產生鎮靜效果。影響血清素系統，某些抗精神藥物(特別是第二代抗精神病藥，如奧氮平和喹硫平)能夠阻斷5-HT_{2A}受體，這也與調節睡眠有關，可能幫助患者更容易入睡。阻斷組織胺H₁受體，組織胺在中樞神經系統中也與覺醒有關。許多抗精神

藥物通過阻斷H₁受體，達到類似抗組織胺劑的鎮靜作用，幫助入睡。

常用於輔助治療失眠，特別是與焦慮、抑鬱或精神病相關的失眠。低劑量時的鎮靜效果較為顯著，但長期使用可能引發代謝綜合症等副作用。

長期使用可能導致體重增加、代謝紊亂(如糖尿病、高血脂)、心血管問題、錐體外症狀等。因此，應權衡助眠效果與潛在風險。

五、抗組織胺藥

抗組織胺藥物分為兩大類，第一代抗組織胺藥物，較早出現，有苯海拉明(diphenhydramine)，幫助減少過敏反應與引起嗜睡。第二代抗組織胺藥物，比較新的藥物，如洛卡特普(loratadine)和西替利嗪(cetirizine)，主要減少過敏症狀，並且比較少引起嗜睡。

抗組織胺藥物的作用是阻止「組織胺」來減少過敏反應。第一代抗組織胺藥物，會引起嗜睡、口乾、視力模糊、尿路滯留。第二代抗組織胺藥物副作用較少，仍有可能引起頭痛、乾口、輕微嗜睡等。

六、乙醯膽鹼刺激劑

乙醯膽鹼刺激劑是一類藥物⁹，增加大腦和神經系統中乙醯膽鹼的作用。幫助神經訊號在神經系統中傳遞。兩種類型，可逆性乙醯膽鹼酯酶抑制劑，暫時阻止乙醯膽鹼在神經中被分解，讓乙醯膽鹼的作用時間變長，如美金剛(donepezil)和加蘭他敏(galantamine)。與不可逆性乙醯膽鹼酯酶抑制劑，長時間地阻止乙醯膽鹼酯酶的

作用，使乙醯膽鹼的濃度持續提高。通過抑制乙醯膽鹼酯酶這種酶的活動，改善與記憶和認知相關的功能。副作用有噁心和嘔吐，腹瀉，肌肉抽搐或疼痛以及失眠。

交互作用，如抗膽鹼藥物，會降低乙醯膽鹼刺激劑的效果。非類固醇抗炎藥 (NSAIDs)，會增加消化道副作用的風險。乙醯膽鹼刺激劑通常用來治療認知功能下降的疾病，例如阿滋海默症。幫助改善患者的記憶和學習能力，並非治癒該疾病，而是改善症狀以及延緩症狀惡化。

七、褪黑素、草藥和補充劑

草藥和補充劑的定義，草藥是來自植物的天然產品¹⁰，用於改善健康或疾病。如薄荷、洋甘菊和人參。補充劑是指用來補充飲食的營養素或其他物質，可以是維生素、礦物質、氨基酸等，如維生素C補充劑可以幫助我們的免疫系統。

草藥在助眠方面有著悠久的使用歷史，許多草藥因其鎮靜和放鬆效果而被用來改善睡眠品質。常見助眠草藥的作用機轉與臨床應用，顯草根含有多種活性成分，包括顯草酸和顯草酮，這些化合物被認為通過影響 GABA (γ-氨基丁酸) 系統起作用。GABA 是一種主要的抑制性神經遞質，能幫助降低中樞神經系統的興奮性，從而引發放鬆和鎮靜作用。西番蓮含有類黃酮和苯並吡喃類化合物，這些成分也與 GABA 系統有關，增加 GABA 的可用性，從而產生鎮靜效果。甘菊含有多種活性成分，特別是黃酮類化合物，如沒食子酸，這些成分具有溫和的鎮靜效果。其與 GABA 系統的相互作用可能是其鎮靜作用

的主要機制。

褪黑素 (Melatonin) 是由松果體自然產生的激素。主要作用是幫助調節我們的睡眠-覺醒周期，讓我們知道何時該睡覺，何時該醒來。通常歸類為「膳食補充劑」不是藥品。在許多國家被認為是自然產物，不需要處方。褪黑素是天然激素，調節睡眠-覺醒周期，對於時差和老年人有效。

褪黑素的作用在當天黑時，體內的褪黑素濃度會升高，大腦會放鬆、準備入睡了。早上陽光出來，褪黑素的濃度會下降，感覺清醒。服用褪黑素補充劑時，模擬這種自然的激素變化，調整我們的睡眠時間。除了少數的白天嗜睡，頭痛，噁心，眩暈與情緒波動外，一般而言是安全的。

八、其他如 Pramipexole

Pramipexole 是一種多巴胺受體刺激劑^{11,12}，用於治療帕金森病和不寧腿綜合症。可以改善這些患者的睡眠品質，可能引起噁心、頭暈和嗜睡等副作用。

肆、結論

總之，助眠藥物的使用需要謹慎，藥師可以依據患者的具體情況，選擇合適的藥物並密切監測其反應。認知行為療法和睡眠衛生應作為失眠治療的首選，藥物治療應僅在其他治療無效時考慮使用。應強調非藥物干預，治療共病狀況。

助眠藥物在改善睡眠品質方面具有一定的效果，但其使用需謹慎。在推薦和指導患者使用助眠藥物時，應充分考慮患者

的具體情況，選擇合適的藥物，並提供全面的藥物資訊和建議。通過這些措施，可

以最大限度地提高助眠藥物的療效，並減少其潛在的風險。

An Overview of Over-the-Counter Sleep Aids

Fang-Chih Wu

Department of Pharmacy, VitalGrain BioTechnology Limited Company

Abstract

With the increasing prevalence of sleep issues among adults in Taiwan, pharmacists must consider multiple factors when assisting patients in managing sleep disorders. The selection of sleep aids should not only improve sleep quality but also enhance daytime functionality. Commonly used medicines include antihistamines, melatonin, antidepressants, and benzodiazepine hypnotics. Antihistamines can have sedative effects but may cause anticholinergic side effects in elderly patients. Melatonin helps regulate circadian rhythms, but long-term use requires careful attention to dosage. Low-dose antidepressants can improve sleep but come with risks such as hypotension. Due to the potential for dependence, benzodiazepines are not suitable for long-term use, whereas non-benzodiazepines have relatively fewer side effects. Pharmacists need to tailor sleep aid regimens based on each patient's specific conditions, overall health status, and concurrent medications to maximize efficacy while minimizing adverse effects.

參考資料：

1. Nutt DJ, Malizia AL: New insights into the role of the GABA(A)-benzodiazepine receptor in psychiatric disorder. *Br J Psychiatry* 2001;179:390-6. (In eng) DOI: 10.1192/bjp.179.5.390.
2. Griffiths RR, Wolf B: Relative abuse liability of different benzodiazepines in drug abusers. *J Clin Psychopharmacol* 1990;10(4):237-43. (In eng)
3. Wagner J, Wagner ML: Non-benzodiazepines for the treatment of insomnia. *Sleep Med Rev* 2000;4(6):551-581. (In eng) DOI: 10.1053/smr.2000.0126.
4. Rickels K, Rynn M: Pharmacotherapy of generalized anxiety disorder. *J Clin Psychiatry* 2002;63 Suppl 14:9-16. (In eng)
5. Neubauer DN: The evolution and development of insomnia pharmacotherapies. *J Clin Sleep Med* 2007;3(5 Suppl):S11-5. (In eng)
6. Lenze EJ, Mulsant BH, Roose SP, et al: Antidepressant Augmentation versus Switch in Treatment-Resistant Geriatric Depression. *New England Journal of Medicine* 2023;388(12):1067-1079. DOI:10.1056/NEJMoa2204462.
7. Muench J, Hamer AM: Adverse effects of antipsychotic medications. *Am Fam Physician* 2010;81(5):617-22. (In eng)
8. Leucht S, Corves C, Arbter D, et al: Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. *Lancet* 2009;373(9657):31-41. (In eng) DOI: 10.1016/s0140-6736(08)61764-x.

9. Cholinesterase inhibitors and opiate antagonists in patients with Alzheimer's disease. *N Engl J Med* 1983;309(9):555-6. DOI: 10.1056/NEJM198309013090913.
10. Ahn JY, Chu H, Leem J, et al: Effectiveness and safety of traditional herbal medicine on cardiac arrhythmic condition: A systematic review and meta-analysis of randomized control clinical trial. *Medicine (Baltimore)* 2024;103(23):e38441. (In eng) DOI: 10.1097/md.00000000000038441.
11. Proctor A, Bianchi MT: Clinical pharmacology in sleep medicine. *ISRN Pharmacol* 2012;2012:914168. (In eng) DOI: 10.5402/2012/914168.
12. Pillitteri JL, Kozlowski LT, Person DC, et al: Over-the-counter sleep aids: widely used but rarely studied. *J Subst Abuse* 1994;6(3):315-23. (In eng) DOI: 10.1016/s0899-3289(94)90502-9.